

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Fisioterapia en Artritis Juvenil

Lic. Cesar Borja Arenas

Tecnólogo M. en Terapia Física y Rehabilitación

Docente

Presente.



Reconocer las principales características clínicas de la Artritis Juvenil y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

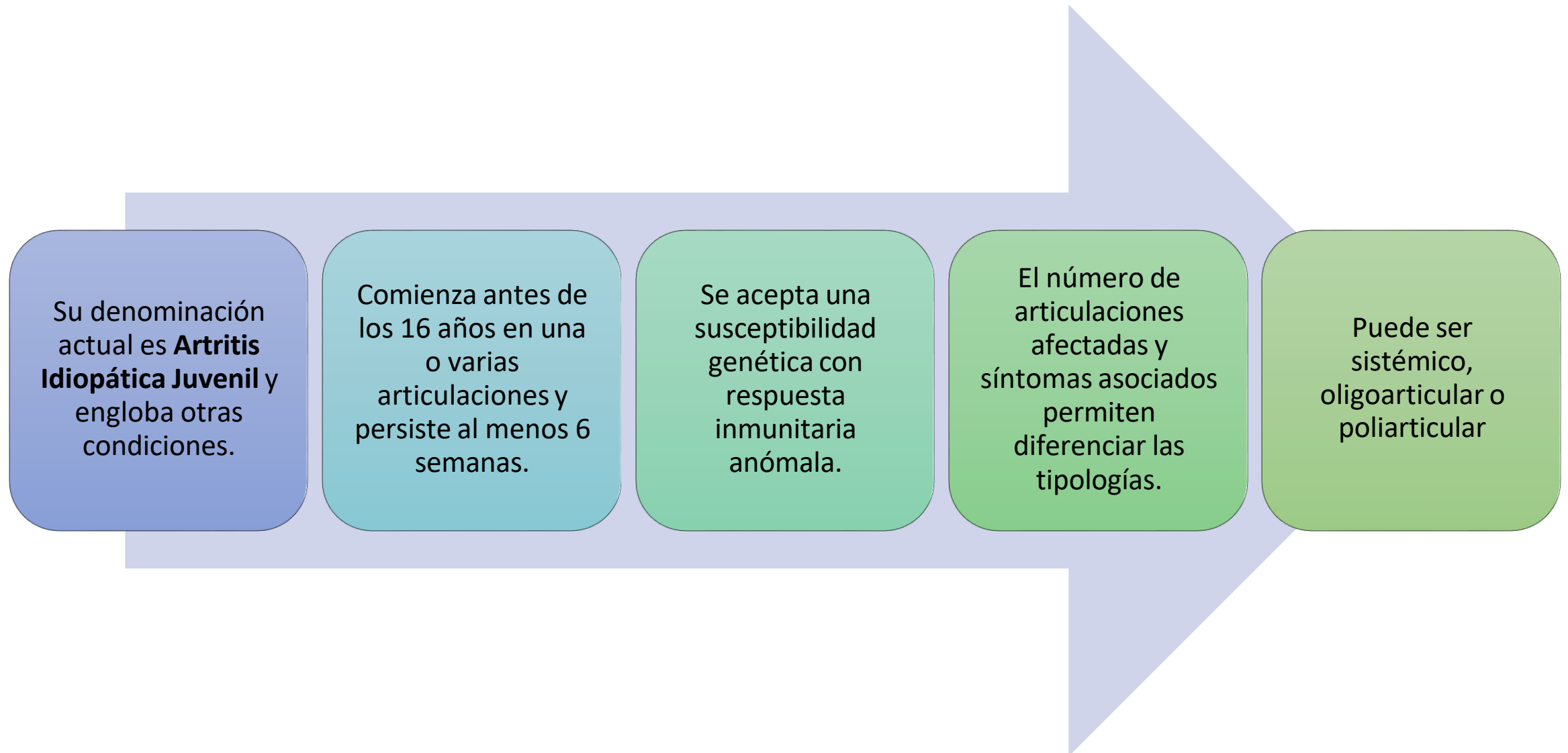
Semana 04: Afecciones sistémicas en reumatología – Fisioterapia en Artritis Juvenil

- 1. Artritis Juvenil**
- 2. Signos y síntomas**
- 3. Curso de enfermedad**
- 4. Evaluación y Pronóstico**
- 5. Objetivos**
- 6. Programa de tratamiento**





“Enfermedad reumatológica autoinmune inflamatoria, crónica y de causa desconocida que afecta a niños y adolescentes”



Artritis Idiopática Juvenil Sistémica



Representa el **10%** de todas las AIJ, aparece antes de los 6 años y al inicio predominan síntomas extra articulares. En más del 50% de casos es policíclica.



Hipertermia

- Fiebre de inicio agudo y con más de 2 semanas de progreso.
- Mal respuesta a los antitérmicos y afectación del estado general.



Exantema

- De carácter máculo-papuloso principalmente en tronco y extremidades.
- Se intensifica ante el calor y rascado, pero disminuye cuando la fiebre baja.



Artritis

- Inflamación y dolor intenso en articulaciones del miembro inferior y luego superior.
- Se asocian mialgias y artralgiás que pueden venir desde el inicio de la fiebre.



Afecciones en órganos

- Adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia.
- En estudio analítico: anemia, leucocitosis y trombocitosis.

Artritis Idiopática Juvenil Oligoarticular



Es la forma más común de AIJ (**60%**) y afecta principalmente a niñas. Las articulaciones objetivo son **4 o menos** y puede ser **persistente o extendida** en los primeros 6 meses de evolución.



Monoartritis de miembro inferior

- La mayoría comienza con una artritis en rodilla o tobillo.
- Existe dolor aunque soportable.



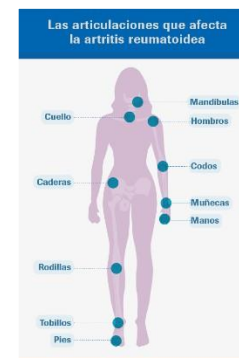
Impotencia funcional

- Debido al dolor y a la inflamación inicial y consecuente la función tiende a disminuir en el paciente.



Afectación oftalmológica

- En forma de uveítis anterior o de iridociclitis crónica muy comúnmente señalado como “ojo rojo” por el paciente o familiar.



Número de articulaciones

- La cantidad de articulaciones puede quedar permanente (tipo 1) o extenderse (tipo 2) acercándose más a un tipo poliarticular.

Artritis Idiopática Juvenil Poliarticular



Representa el **20%** de las AIJ y es más frecuente en niñas afectando de **5 a más articulaciones** en los primeros 6 meses de enfermedad. Puede ser **con FR+** o **con FR-**. Tiende a ser precursor de la artritis reumatoide (adulto).



Afectación articular simétrica

- Suelen afectarse articulaciones bilaterales como caderas, tobillos, codos, manos, pies, temporomandibular, entre otros.



Impotencia funcional

- Debido al dolor y a la tumefacción articular con presencia de calor.
- La aparición de tenosinovitis o nódulos puede disminuir más la funcionalidad.



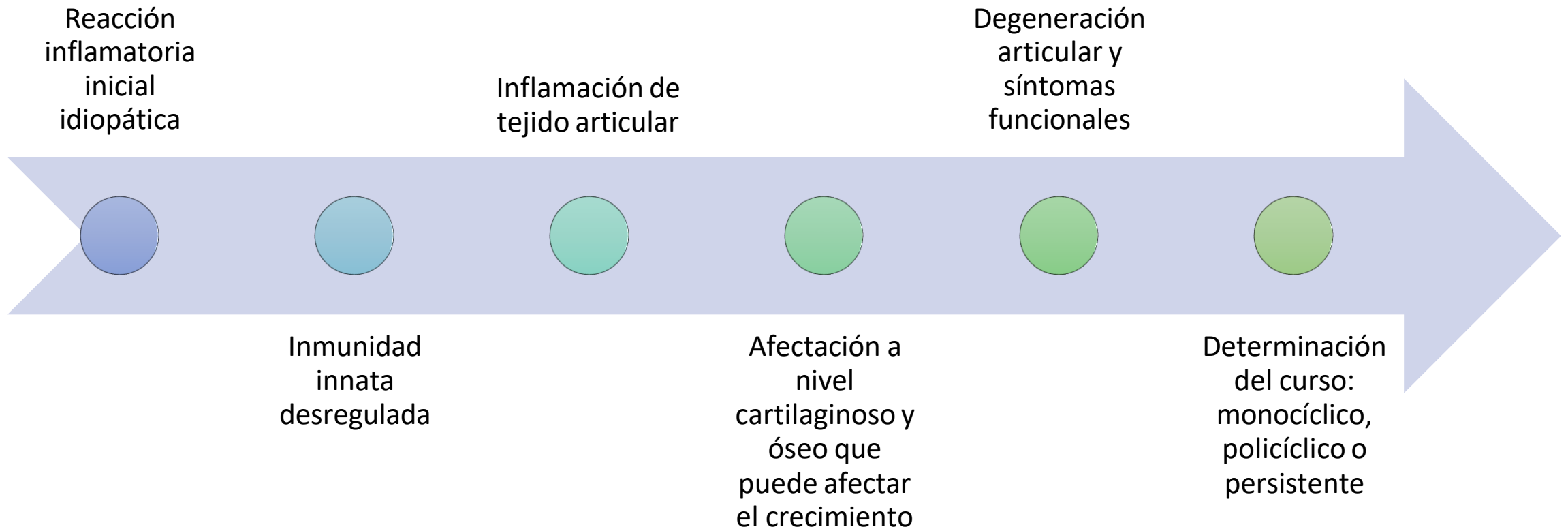
Rigidez

- Puede no estar asociada a cuadros inflamatorios.
- Principalmente rigidez matutina.

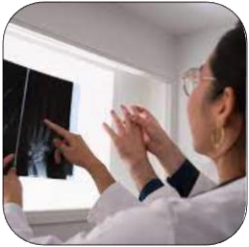


Factor Reumatoide +/-

- El subtipo con FR+ tiende a tener solo un pico de incidencia entre los 9 y 12 años.
- El subtipo con FR- tiende a tener dos picos de incidencia. Uno entre 2 y 4 años, y otro entre los 10 y 14 años.



Evaluación médica



Radiografías para detectar daño articular estructural y la Resonancia Magnética para visualizar las características de la enfermedad a nivel sinovial.



Análisis de sangre para identificar niveles séricos y FR.



Clínica (signos y síntomas del paciente menor de edad)

Evaluación fisioterapéutica



Entrevista sobre antecedentes, historia de la enfermedad y datos afines al paciente y al familiar.



Inspección de la zona a tratar para analizar presencia de inflamación articular (o no) y características de la piel, así como la presencia de cambios posturales.



Valoración de las características del dolor (intensidad, localización, duración, etc).



Exploración de los rangos de movimiento de las articulaciones comprometidas.

Evaluación fisioterapéutica



Exploración de la fuerza muscular de las articulaciones comprometidas.



Palpación de zonas/estructuras dolorosas y valoración de la sensibilidad.



Medición de la capacidad funcional general y específica según cuestionarios, índices o escalas.



Valorar la presencia de síntomas psicológicos agregados y los objetivos personales del menor, así como la intervención del entorno en el proceso.



- Grado de afectación
- Categoría clínica
- Suma de manifestaciones clínicas
- Respuesta al tratamiento

Disminuir el dolor y rigidez articular

Mejorar o mantener los rangos de movimientos articular

Aumentar la fuerza muscular y resistencia

Mejorar la funcionalidad e independencia del paciente

Educación para la salud tanto para el paciente como para su familia

**Disminuir
dolor y
rigidez**

**Termoterapia
(CHC, parafina)**

**Electroterapia
analgésica**

**Masoterapia
relajante**

Hidroterapia

**Mejorar o
mantener los
rangos de
movimientos
articular**

Hidroterapia

**Estiramientos
osteomusculares
progresivos**

**Movilizaciones activo-
asistidas respetando
el rango de dolor**

**Aumentar
la fuerza
muscular y
resistencia**

Ejercicios libres de
articulaciones
cercanas y resistidos
progresivos

Ejercicios isométricos

Programa de
ejercicios aeróbicos
regulados

Mejorar la
funcionalidad
e
independencia
del paciente

Enfocarse a actividades
funcionales (praxias
manuales)

Considerar gustos y
preferencias

Si el paciente usa
ortesis, incluirlos en la
actividad

Educación
para la salud
tanto para el
paciente como
para su familia

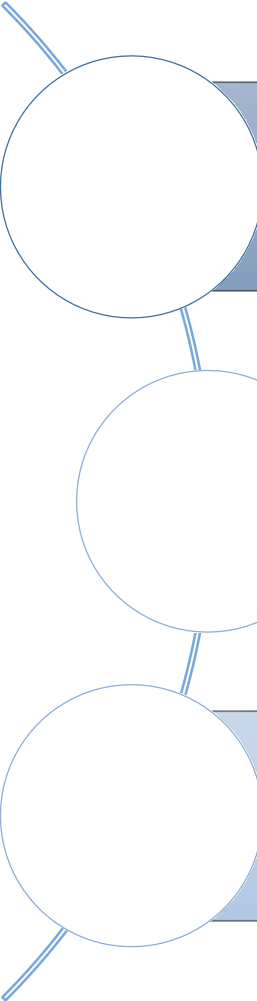
Educación respecto a la
patología

Enseñar posiciones de
reposo y protección articular

Plantear hábitos de actividad
física regulada

Afianzar el papel del entorno
y compromiso constante





1. Los síntomas generales de los tipos de AIJ suelen ser el dolor, la rigidez y la disminución del movimiento en niños y adolescentes.

2. La AIJ presenta tres tipos: sistémica, oligoarticular y poliarticular; diferenciándose por la sintomatología y el número de articulaciones afectadas.

3. Para la mejora de la calidad de vida y funcionalidad de los niños con AIJ se recomienda un diagnóstico temprano y un pronto tratamiento multidisciplinario.

- Charpentier R. Abordaje de la artritis idiopática juvenil. Revista Médica Sinergia. 2021; 6(1): 1-12. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/502/1075>
- Solís P. Artritis idiopática juvenil (AIJ). Pediatr Integral. 2013; 17(1): 24-33. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2013/xvii01/03/24-33%20AIJ.pdf>
- Colegio Estadounidense de Reumatología. Artritis Juvenil. Estados Unidos; 2019. Disponible en: <https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Arthritis-Juvenil-Fact-Sheet.pdf>
- Ministerio de Salud. Guía clínica: Artritis idiopática juvenil. Santiago: Minsal, 2010. Disponible en: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Artritis-Idiop%C3%A1tica-y-Reumatoidea-Juvenil.pdf>

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



**Realiza un cuadro comparativo
sobre las diferencias entre la
artritis reumatoide y la artritis
juvenil investigando
publicaciones científicas previas**



MUCHAS GRACIAS

Presente.